

TEMA 3.51 • OBSTETRICIA

Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto)

PERFIL EUNACOM 1.03.51
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto)

Definición

TABLA 3.51.1: SITUACIÓN VS UMBRAL	
SITUACIÓN	UMBRAL
Parto vaginal	> 500 mL
Cesárea	> 1.000 mL
Cesárea + histerectomía	> 1.500 mL

Clasificación: - **Precoz:** < 24 horas postparto - **Tardía:** 24 horas a 6 semanas postparto

Metrorragia Precoz — Las 4T

TABLA 3.51.2: CAUSA VS FRECUENCIA		
CAUSA	FRECUENCIA	MECANISMO
Tono (atonía uterina)	70% — la más frecuente	Útero no se contrae → fondo sobre el ombligo
Trauma	Frecuente	Laceraciones + hematomas del canal del parto
Tejidos	Frecuente	Restos ovulares / placentarios
Trastornos de coagulación	Infrecuente	Enfermedad de von Willebrand y similares

Evaluación Inicial: Palpación del Útero

TABLA 3.51.3: ESTADO DEL ÚTERO VS SOSPECHA		
ESTADO DEL ÚTERO	SOSPECHA	PRIMERA MEDIDA
Retraído (fondo bajo el ombligo)	Laceración del canal	Revisión manual/instrumental del canal del parto
Distendido (fondo sobre el ombligo)	Atonía uterina	Masaje uterino + uterotónicos

Manejo de Atonía Uterina (en orden)

Siempre iniciar con ABC + vía venosa + suero fisiológico.

Paso 1: Masaje Uterino + Uterotónicos

TABLA 3.51.4: FÁRMACO VS ORDEN	
FÁRMACO	ORDEN
Oxitocina	1ª línea
Carbetocina	Análogo de oxitocina
Metilergonovina (ergotamínico)	2ª línea
Misoprostol	3ª línea

Paso 2: Revisión Manual/Instrumental del Canal

(También descartar desgarros aunque el útero esté distendido)

Paso 3: Ligaduras

TABLA 3.51.5: LIGADURA VS ORDEN	
LIGADURA	ORDEN
B-Lynch	Puntos de compresión del útero — 1ª
Arterias uterinas	2ª
Arterias hipogástricas	3ª

Paso 4: Histerectomía

Última línea — cuando todo lo anterior ha fallado.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El orden de los pasos es lo que se pregunta en el EUNACOM: siempre seguir la secuencia correcta.

Metrorragia Tardía (> 24 horas)

Causas

- Restos ovulares / placentarios — más frecuente
- Endometritis puerperal

Conducta: siempre ATB EV + legrado

TABLA 3.51.6: COMPONENTE VS DETALLE	
COMPONENTE	DETALLE
ATB EV	Siempre (riesgo de diseminar infección si se lega sin cobertura)
Legrado	Para remover restos ovulares

NOTA CLÍNICA

Sospechar más endometritis que restos si viene con fiebre, dolor, leucorrea/mal olor, o si han pasado ≥ 5-7 días postparto. Aun sin estos signos → dar ATB igualmente antes del legrado.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto): Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto) ## Definición | Situación | Um... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Definición
- Metrorragia Precoz — Las 4T
- Evaluación Inicial: Palpación del Útero
- Manejo de Atonía Uterina (en orden)
- Paso 1: Masaje Uterino + Uterotónicos
- Paso 2: Revisión Manual/Instrumental del Canal
- Paso 3: Ligaduras

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (METRORRAGIAS PUERPERALES (HEMORRAGIA POSTPARTO))**PREGUNTA 1**

En relación a Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto): Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto) ## Definición | Situación | Um... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto) requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Metrorragias Puerperales (Hemorragia Postparto). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: METRORRAGIAS PUERPERALES (HEMORRAGIA POSTPARTO)

:::warning El orden de los pasos es lo que se pregunta en el EUNACOM: siempre seguir la secuencia correcta. ::: ::::note Sospechar más endometritis que restos si viene con fiebre, dolor, leucorrea/mal olor, o si han pasado $\geq 5-7$ días postparto.